

# **Médicaments des Urgences**

**Dr.KHERBA\_N**

## Sommaire

Adrénaline

Aspegic

Atarax

Atropine

Atrovent

Cordarone

Depakine

Dexamethasone

Dobutrex

Dopamine

Ephedrine

Flagyl

Flumazenil

Gardenal

Héparine rapide

Hydrocortisone

Isuprel

Lasilix

Lenitral

Loxen

Mg

Mopral

Morphine

Noradrénaline

Perfalgan

Phenergan

Primperan

Propranolol

Salbutamol

Solumedrol

Spasfon

Tamgésic

Terbutaline

Valium

Venofer

Ventoline

Vitamine K

Zovirax

## Adrénaline

■ **Epinéphrine**=> Vasoconstricteur (alpha),  
Vasodilatateur (beta)

■ Amp 1\_0.5\_0.25mg/1ml

■ Dilution dans SSI

■ 0.01mg/kg, Max :

■ 0.5mg pour un adulte

■ 0.3mg pour un enfant

■ À renouveler chaque 10min

■ Intrabronchique: 100ug/kg

■ IVD: 10ug/kg

■ Sc: 10\_15ug/kg

■ Perfusion: 0.025\_1ug/kg/min



## Indications:

- Arrêt cardiaque:
- 1mg/3mn en IVD
- 3mg/10ml en intratrachéal
- Enfant: 10\_30ug en intratrachéale chaque 3\_5min
- État de choc: 0.01ug/kg/mn en IV
- Anaphylactique: 0.1\_0.2mg en IVL
- 1mg dans 10ml de SSI
- Hypovolémique: 0.05\_0.5u/kg/mn
- Asthme aigu grave:
- 0.01\_1ug/kg/mn en IV



## Contre indications:

- TDR ventriculaire
- Cardiomyopathies obstructives
- Insuffisance coronaire

## Aspegic

- Adulte: 0.5\_1g en IV
- Antiagrégant plaquettaire 250mg en IV
- Enfant: 10\_25mg/kg/j en 6inj
- Dilution dans le SG ou SSI



### Indications

- Antipyrétique, antalgique
- Antiagrégant plaquettaire (IDM)
- Anti-inflammatoire



### Contre indications:

- UGD
- Virose
- Allergie à l'aspirine
- Risque hémorragique
- 3ème trimestre de grossesse

## Atarax

### Hydroxyzine

■ 50\_100mg en IM ou IVL dilué dans 10ml de SSI en 5mn

#### Indications :

- Tranquillisant (anxiété, agitation)
- Antihistaminique H1 (allergie)

#### Contre indications :

- Glaucome
- Adénome de prostate
- Grossesse 1<sup>er</sup> trimestre



## Atropine

- Antagoniste compétitif de l'Ach
  - Effet: tachycardisant, mydriatique, antispasmodique, antisécrétoire (salivaire, bronchique, gastrique, sudoripare)
  - 0.25mg 1mg/1ml
  - 10\_15u/kg en IVL 0.5min
- ✓ Indications:
- BAV
  - Bradycardie sinusale: 0.5\_1mg en IVD
  - Douleur aiguë spasmodique (colique néphrétique, biliaire, digestive)
  - Intoxication par les anticholinestérasiques organophosphorés: 1\_2mg/5mn en IVD

## Contre indications:

- Glaucome à angle fermé
- Hypertrophie prostatique
- Iléus paralytique
- Tachycardie
- IC

## Atrovent

### ■ Unidose :

- Adulte et Enfant >5ans : 0.5mg/2ml ou 2cc=> 1 récipient/5ml Aérosol
- Enfant <5ans : 0.25mg/2ml ou 2cc=> 1 récipient/4ml Aérosol
- Autorisé chez les cardiopathes



### Indications :

- Crise d'asthme sévère
- Décompensation BPCO
- État de mal asmathique

## Cordarone

■ **Amiodarone** => antiarythmique

■ Amp 150mg/3ml

■ Dose de charge : 5mg/kg en IVL sur 15\_30min

Puis relais au PSE 1amp sur 8h

■ Dose d'entretien : 10mg/kg/24h

■ Seulement le SG5%, jamais inj rapide



Indications :

■ TDR ventriculaire et supraventriculaire



Contre indications :

■ BAV

■ Bradycardie

■ Grossesse

- Dysthyroïdies
- Allergie à l'iode
- Hypotension artérielle
- Troubles de conduction
- Collapsus cardio-vasculaire
- Insuffisance cardiaque sévère

# Depakine

## Valproate de sodium

- Bolus 15mg/kg en IVL sur 3min puis relais au PSE à 1mg/kg/h
- Dilution dans sérum physiologique

### Indications :

- État de mal épileptique

### Contre indications :

- Affections hépatiques

## Dexamethasone

- 1 amp de 4mg

● Inj : 0.5mg/kg/j en IM max : 12mg

Cp/inj

- Adulte : 0.5\_9mg/kg/j

- Ou 0.6mg/kg en IM

Échec après 1h : 0.4mg/kg

- Laryngite : Nébulisation=> 1 amp + 1cc

Adrénaline + 4cc SSI

## Dobutrex

### ■ Dobutamine

- Amp 250mg/10ml ; 2.5\_20ug/kg/mn
- Ne pas arrêter brutalement la perfusion
- Dilution que dans le SG5% ou SSI
- Dilution :  $\text{poids} \times 3 = \text{dose en mg à diluer dans 50ml}$

$1\text{ml/h} = 1\text{ug/kg/mn}$

### Indications :

- État de choc cardiogénique
- Choc septique à la phase hypokinétique

### Contre indications :

- Cardiomyopathies obstructives
- Valvulopathies aortique
- Tamponnade



## Dopamine

● Amp 200mg/5ml, 50mg/10ml

▪ Action: dose dépendante

✓ Indications:

▪ État de choc

## Ephedrine

- Amp 30mg/1ml

 Indications :

- Collapsus vasculaire 3\_9mg en IVD

## Flagyl

- 30mg/kg/j

- Durée : 7j

- 3/j

- Sirop : 125mg (Nrs)/ 200mg (Enfant)

- 1cam 3/j

- Cp : 1cp 3/j

- 250mg : >13ans

- 500mg : Adulte

- Flacon : 500mg/8h pour un adulte

Enfant : 20mg/kg/j

## Flumazenil

### ■ Anexate

- Amp 0.5mg/5ml et 1mg/1ml

0.2\_0.3/min en IV jusqu'à au réveil, max : 2mg

- Relais au PSE 0.1\_0.4mg/h



### Indications :

- Antidote dans les surdosages aux BZD



### Contre indications :

- Épilepsie
- Intoxication polymédicamenteuse

# Gardenal

## ■ Phénobarbital

⇒ Anticonvulsivant, sédatif, hypnotique

■ Solution inj : 40mg/2ml en IM ou IVL sur 15min

■ Dilution dans 500 de SG ou SSI

■ Posologie :

■ Adulte : 10mg/kg/j

■ Enfant : 20\_40mg/j

■ Nourrisson : 10\_20mg/j

 Indications :

■ Épilepsie généralisée ou partielle

■ État de mal convulsif

## Contre indications :

- Porphyries
- Insuffisance respiratoire sévère
- Hypersensibilité aux Barbituriques

## Heparine rapide

- Flacon 5ml
- 400\_600 ui/kg/24h au PSE
- Posologie en fonction des résultats de l'hémostase

### Indications :

- La nécessité d'anticoagulants efficaces :
- Phlébite
- Embolie
- Infarctus

### Contre indications :

- ATCD de Thrombopénie sous Héparine
- Lésions susceptible de saigner

 Effets secondaires :

- Thrombopénie
- Hémorragie



## Hydrocortisone HHC

- Adulte : 100\_200mg en IV
- Enfant : 5mg/kg
- Dilution dans 2cc de SG5% ou SSI

### Indications :

- Laryngite
- Œdème laryngé
- Œdème de Quincke
- Asthme aigu grave
- Toux sèche gênante

## Isuprel

- **Isoprenaline** amp 0.2mg/ml
- 0.01\_0.1u/kg/min
- 5amp (1mg) dans 250ml de SG5%



### Indications :

- Bradycardie par BAV
- Torsade de pointe
- BAV 3<sup>ème</sup> degré



### Contre indications :

- Insuffisance coronarienne aiguë

## Lasilix

■ **Furosémide**=> Diurétique de HA, inhibe la réabsorption du Na et Cl

■ Amp 20mg/2ml 40mg

■ En IM ou IV, jamais dilué

■ 20\_80mg en IVD

■ 0.5\_2mg/kg/j



Indications:

■ IR

■ OAP

■ HTA pulmonaire

■ Poussée hypertensive

■ Insuffisance cardiaque

■ Rétention hydrosodée

■ Hypercalcémie aiguë

- Hyperkalémie
- Néphropathie

### Contre indications:

- Encéphalopathie hépatique
- Hypersensibilité aux sulfamides
- Troubles hydro électrolytiques non corrigés
- Oligo anurie sur obstacle des voies urinaires

### Effets secondaires:

- Troubles hydroélectriques: hypoNa, hypoK
- Hypovolémie, hypoTA
- Déshydratation
- Troubles métaboliques (Glycémie)

## Lenitral

### Lenitral/Nitrocine (Trinitrines)

- Dérivé nitré=> Vasodilatateur, antiangineux
- Amp 3mg/2ml et 15mg/10ml
- 1\_3mg/h en PSE
- OAP hypertensif : dose de charge 1\_3mg en IVD à renouveler après 10mn
- Dilution dans le SG5% ou sérum physiologique



#### Indications :

- IDM
- OAP
- Angor instable
- HTA systolique



#### Contre indications :

- Hypotension sévère
- ICD aigue

## Loxen

- **Nicardipine**=> antihypertenseur, Inhibiteur calcique, Vasodilatateur artériel
- Amp 10mg/10ml 5mg/5ml
- Strictement en IV dilué ou en perfusion
- 1cc dilué dans SG5% chaque 1h, max: 10mg
- 2.5mg en IV en 5min, à renouveler chaque 5min, max: 10mg
- Relais au PSE 2\_4mg/h à adapter par palier 0.5mg/h
- Dilution dans le SG
- Dose de charge: 1mg en IVL/3min
- Dose d'entretien: 1\_6mg/h en PSE
- Enfant: 0.5\_3mg/kg/24h

 Indications:

- Dissection aortique
- Urgences hypertensives
- Menace d'accouchement prématuré
- Prééclampsie

## Mg

- En IVL dilué dans le SG

### Indications :

- Pic HTA
- DNV/Convulsion
- HypoMg/Hypokalémie
- Éclampsie/Prééclampsie
- Palpitations/Tachycardie
- Arythmie digitalique
- Anxiété/Agitation
- Torsade de pointe
- Crise d'asthme
- Troubles de rythme



## Contre indications :

- Myasthénie
- Hypotension sévère

## Mopral

### Omeprazole

- 40mg, en perfusion IV
- Si hémorragie active surtout d'origine ulcéreuse: bolus 80mg en IV  
puis 200mg/24h à la SAP
- 5amp (200mg) ramenées jusqu'à 50cc SG5% en PSE

Débit: 2cc/h (8mg/h)

- Enfant => 1-2mg/kg/j diluée dans 250cc de SG5% ou SSI9%
- Adulte: 1amp
- Enfant: 1/2 amp

✓ Indications :

- RGO
- UGD
- Hémorragie digestive

## Morphine

- Amp 10mg/1ml
- 0.1mg/kg S/c ou IV
- Si insuffisant à compléter par bolus de 1mg/5 à 10mn jusqu'à l'amélioration



### Indications :

- Douleur résistante aux autres antalgiques



### Contre indications :

- TC grave en l'absence de ventilation contrôlée
- IHC sévère

## Noradrénaline

- Amp 8mg/4ml
- 0.5\_3u/kg/min
- Dilution dans le SG

 Indications :

- États de choc

## Perfalgan

- En IV 500mg : Enfant 1g : Adulte
- Enfant : 15mg/kg/j Soit 1.5ml/kg
- Max 3g/j
- 1.5cc/kg
- 250/500mg

Poids + 1/2Poids = ?cc

- <10kg : 7.5mg × poids/6h perf IV 0.75cc/kg
- >10kg : 15mg × poids/6h perf IV 1.5cc/kg

## Phenergan

- **Prométazine**=> AH sédatif
- IM ou IV diluée

 Indications :

- DNV
- Urticaire
- Agitation
- Troubles de sommeil

## Primperan

- Max 5j 1\_3/j

- Sirop : >1ans 1ddp 1\_3/j

- 15\_19kg : 2mg

- 20\_29kg : 2.5mg

- 30\_60kg : 5mg

- >60kg : 10mg

- Cp : 10mg >18ans 1cp 1\_3/j

- Inj : en IM ou IV diluée dans 2cc de SG ou SSI

- ✓ Indications :

- DNV

- Crise de panique

- Nausées/vomissements

- ⊖ Contre indications :

- Occlusion intestinale



# Propranolol

## Alvocardyl

- Amp 5mg/5ml
- 0.5\_1mg en IVD chaque 2min jusqu'à effet, max : 10mg
- Dilution dans SG ou physiologique
- Injection trop rapide risque de bradycardie

- Indications :
- TDR supraventriculaire

### Contre indications :

- IC
- BAV
- Asthme
- Maladie de l'oreillette
- En association avec le Cordarone

## Salbutamol

- Bronchodilatateur, Utéro\_relaxation
- 0.5mg/1ml 5mg/5ml
- Nourrisson : 0.03cc/kg max : 1cc + 2cc de SSI

### Indications :

- Bronchospasme
- Crise d'asthme sévère
- État de mal asmathique
- Menace d'accouchement prématuré

### Contre indications :

- IDM aigue
- Angor instable
- Insuffisance coronarienne

 Effets secondaires :

- Hypotension artérielle
- Tachycardie
- Agitation
- Vertiges
- Nausées

## Solumedrol

- **Méthylprédnisolone** (Anti\_inflammatoire)
- 20mg 40mg 80mg 120mg en IM ou IVD
- 1\_2mg/kg en IVL sur 5\_10min
- Dilution dans SG ou SSI
- Traumatisme médullaire : 30mg/kg/45min puis 5,4mg/kg/h pdt les 23h restantes

### Indications :

- Crise d'asthme
- Piqûre d'insecte
- Réaction allergique
- Œdème de Quincke
- Traumatisme du rachis
- Réactions inflammatoires
- Œdème laryngé, laryngite, épiglottite

## Effets secondaires :

- HTA
- UGD
- Allergie
- Hémorragie digestive
- Arythmie si IV trop rapide

## Spasfon

● Inj : 80mg déjà diluée en IM ou IVD

0.5mg/kg/6h max 3amp/j

■ 5ans<.. $<12$ ans :  $\frac{1}{2}$  amp

■  $>12$ ans : 1amp

● Lyoc 80mg/160mg

■  $>8$ ans : 1lyoc 2/j

■ Adulte : 2lyoc 80mg ou 1lyoc 160mg au moment de crise, à renouveler en cas des spasmes importants sans dépasser 6lyocs de 80mg ou 3 de 160mg

● Suppo : 150mg Adulte 1suppo à la demande  
1\_3/j

 Indications :

- Dysménorrhées
- Colique hépatique
- Colique néphrétique
- Intoxication alimentaire
- Colopathies fonctionnelles

## Tamgésic

- 1amp Sc IM IV Ou 1cp en sublingual
- Enfant: 1/3amp ou 0.002\_0.006mg/kg/6\_8h

Ex: 20kg=> 0.04\_0.12mg/6\_8h en Sc

### Indications :

- Antalgique morphinique

### Contre indications :

- Âgé <15ans
- Intoxication éthylique
- Insuffisance respiratoire
- Insuffisance hépato cellulaire



## Terbutaline

- **Bricanyl**=> Bronchodilatateur,  
Utéro\_relaxation
- Amp 0.5mg/1ml dosette 5mg/2ml
- Nébulisation : Asthme aigu grave
- Aérosol : Nébulisation avec 6\_8l d'O2 de  
5\_10min de Ventoline 5\_10mg (1\_2ml) ou  
Bricanyl 5\_10mg (2\_4ml) + Atrovent 0.5mg/2ml  
uniquement à la 1<sup>ère</sup> Nébulisation
- IVL : ½\_1amp/60kg dans 5min puis relais au  
PSE 0.1\_1ug/kg/mn
- S/c :
- Adulte : ½\_1amp chaque 6h
- Enfant : 10u/kg (1/4amp pour 15kg)

 Indications :

- Hyperkalémie
- Crise d'asthme
- Dyspnée spastique en cas d'insuffisance respiratoire chronique

 Contre indications :

- Affection coronarienne aiguë

## Valium

- **Diazépam**=> antianxiolytique, anticonvulsivant, myorelaxant, sédatif
- Solution inj 10mg/2ml, dans SG ou SSI
- Adulte : 0.1\_0.2mg/kg en IM ou IVL  
10\_20mg 1mg/mn
- Enfant : 0.5mg/kg en IR à renouveler si besoin  
0.1ml de solution par Kg, max : 10mg (1amp)
- Par exemple : 12kg=>  $12/2 = 6\text{mg}$   
30kg=> 10mg puisque c'est la dose max  
0.3mg/kg en IVL

### Indications :

- Urgences neuropsychiatriques : Épilepsie, crise d'angoisse, agitation, crise convulsive
- Intoxication aux chloroquines
- Tétanos

## Contre indications :

- Insuffisance respiratoire et hépatique sévère
- Hypersensibilité aux Benzodiazépines
- Myasthénie

## Effets secondaires :

- Somnolence
- Dépendance
- Sensation ébrieuse
- Syndrome de sevrage

## Vénofer

### Indications :

- Intolérance au fer oral
- Troubles d'absorption intestinale
- Non observance du traitement oral
- Inefficacité du fer oral après 2\_4sem
- Refus ou contre indication à la transfusion
- Anémie modérée à sévère mal tolérée (Hb < 10g/dL)
- Besoins rapides en fer (chirurgie, grossesse à terme, hémorragie)

 1amp de 100mg de fer dans 5ml à diluer dans 100ml de NaCl 0.09% en 1h

Éviter le SG5% (incompatibilité chimique possible)

- FNS de contrôle après 15j

## Ventoline

- Bronchodilatateur
- 1\_2 bouffées 1\_2/j

### Indications :

- Crise d'asthme sévère
- BPCO

### Contre indications :

- Allergie

## Vitamine K1 Konakion

- Amp 10mg/1ml
- 10mg en IVL
- Dilution dans le SG ou SSI

### Indications :

- Surdosage aux AVK

### Contre indications :

- Allergie à la Vitamine K

## Zovirax

- 30mg/kg/24h en 3 perfusions (1h dilution de 50\_100ml)
- A adapter la posologie an cas d'IR

### Indications :

- Méningite herpétique



